

Dialog motywujący *poza uzależnieniami*

Dialog motywujący nie jest alternatywą dla terapii poznawczo-behawioralnej czy innego podejścia — jest paliwem, dzięki któremu każde podejście działa lepiej. Stosuj go wszędzie, gdzie jest ambiwalencja wobec zmiany.

CZAS: 10 min · poziom średni · Brak współpracy z planem; opór; niechęć do zadań

ŹRÓDŁO: Lundahl i in. (2010, 2013)

JAK UŻYWAĆ

Ten arkusz pokazuje, że dialog motywujący jest użyteczny daleko poza uzależnieniami — wszędzie tam, gdzie pojawia się **ambiwalencja wobec zmiany zachowania**: w trzymaniu się leczenia, zmianie stylu życia (dieta, ruch), pracy z młodzieżą, a także jako wsparcie innych terapii. Podaje konkretne zastosowania: rozmowę o przyjmowaniu leków, reagowanie na niewykonane zadania domowe w terapii poznawczo-behawioralnej, planowanie zmiany nawyku oraz pracę z wątpliwościami co do sensu terapii. Pokazuje też, jak łączyć metodę z innymi podejściami: najpierw budowanie motywacji, potem techniki — a metoda wraca, gdy motywacja słabnie.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Częsty błąd to traktowanie dialogu motywującego jako narzędzia „tylko dla uzależnień” — przez co pomija się jego przydatność w innych rodzajach ambiwalencji („chcę schudnąć, ale lubię jeść”, „mam brać leki, ale boję się skutków”). Tymczasem działa on w wielu obszarach jako **styl rozmowy** kompatybilny z każdą terapią. Najlepiej rozumieć go nie jako osobną metodę konkurującą z innymi, lecz jako **paliwo**, które aktywuje motywację będącą fundamentem dalszej pracy. Praktycznie: gdy ktoś nie wykonuje zadań, zamiast „musisz je robić” lepiej z **ciekawością** eksplorować bariery („zauważam, że nie wyszło — jak to wygląda z twojej strony?”); gdy wątpi w sens terapii, można odwołać się do dwóch jego części („część wątpi, część jednak dziś przyszła — opowiedz mi o tej drugiej”). Ważne jest też trafne dawkowanie: dialog motywujący to **styl bazowy i technika startowa**, a nie zamiennik metod takich jak terapia poznawczo-behawioralna tam, gdzie potrzebne są ich konkretne procedury (np. praca z unikaniem w fobii).

01 Gdzie się przydaje

- **trzymanie się leczenia** — „co sprawia, że czasem pomijasz? czego byś potrzebował?”
- **zadania domowe** — „nie wyszło z zadaniem — jak to wygląda z twojej strony?” (ciekawość, nie frustracja)
- **zmiana stylu życia** — „jakie widzisz korzyści? co najtrudniejsze? najłatwiejszy pierwszy krok?”
- **wątpliwości co do terapii** — „część wątpi, część przyszła — opowiedz o tej drugiej”

02 Jak łączyć z inną terapią

- najpierw **buduj motywację** (styl motywujący), potem **techniki** wybranej metody
- styl motywujący **wraca**, gdy motywacja słabnie
- to **styl bazowy**, nie zamiennik metody tam, gdzie potrzebne są jej procedury

03 Gdzie reaguję frustracją zamiast ciekawości

Przy jakim oporze (niewykonane zadania, pomijane leki, wątpliwości) najłatwiej tracisz cierpliwość? Jak brzmiałaby reakcja z ciekawością zamiast nacisku?

SYTUACJA + MOJA REAKCJA Z CIEKAWOŚCIĄ

04 Gdzie wpleść styl motywujący

W której swojej pracy (poza uzależnieniami) styl motywujący mógłby pomóc aktywować motywację, zanim wejdziesz w techniki? Jak to zaplanujesz?

GDZIE I JAK WPLOTE

Klucz: dialog motywujący nie jest alternatywą dla innych terapii, lecz paliwem, dzięki któremu działają lepiej. Stosuj go wszędzie, gdzie jest ambiwalencja — jako styl bazowy, nie zamiennik konkretnych procedur.